PERFIL DE SALUD LOCAL · ATARFE (GRANADA) · INE 18022

Perfil de Salud Local de Atarfe

VERSIÓN 0.2 · 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 · BORRADOR PARA VALIDACIÓN TÉCNICA

Atarfe en datos

Resumen. Atarfe tiene 20.952 habitantes [1] y ha crecido un 16,4 % entre 2014 y 2024, con una edad media de 39 años [2, tabla 1]. Su enfermedad crónica sigue el patrón de la provincia, con más asma, trastorno de ansiedad, obesidad y litiasis urinaria que Granada [2, tabla 6].

Desigualdades. El trastorno de ansiedad registrado duplica en las mujeres el de los hombres [2, tabla 6], y en el Monitor de bienestar socioemocional puntúan más bajo las mujeres y las personas de 25 a 64 años [3]. No hay datos de renta por sección censal en el expediente.

Comunidad. El Ayuntamiento y el Distrito Sanitario reunieron 910 respuestas al Monitor, en papel y por QR, en institutos y otros espacios del municipio [3]. Localiza Salud registra 20 recursos de Atarfe; su validación como activos no está declarada [4].

Salud. El factor más bajo del bienestar socioemocional es el control, que reúne la energía y la tranquilidad: el 50,7 % de quienes respondieron se sintió tranquilo solo en algún momento o en ninguno durante la última semana [3].

Quién vive aquí

Atarfe tenía 20.952 habitantes en 2025, 10.476 hombres y 10.476 mujeres [1] (figura 1). El 17,9 % tiene menos de 15 años y el 13,4 %, 65 o más [1]. Entre 2014 y 2024 la población creció un 16,4 %; en 2023 hubo 189 nacimientos y 109 defunciones, 1.358 inmigraciones y 1.051 emigraciones, y Marruecos es el primer país de procedencia de la población extranjera, con el 31,3 % [2, tabla 1 e introducción].

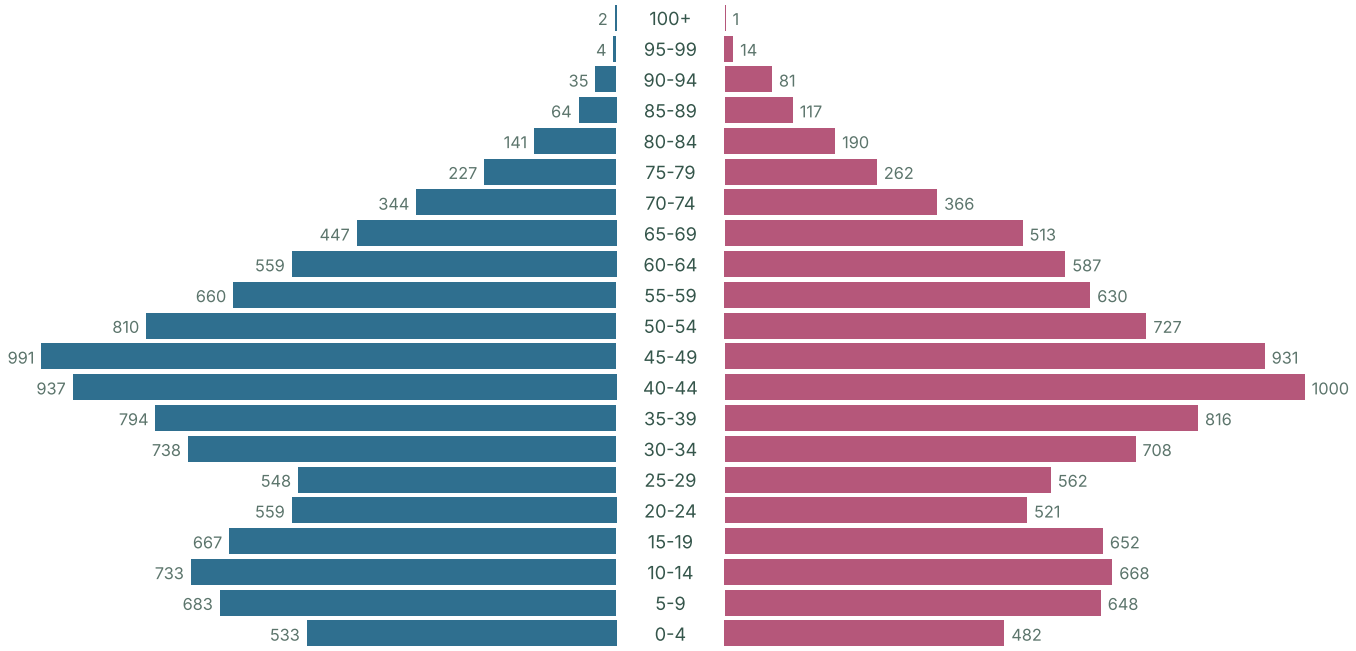


Figura 1. Población de Atarfe por sexo y grupo de edad, 2025 [1]. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha.

El 94,3 % de la población vive en agrupaciones urbanas y el término se clasifica como zona de densidad intermedia [5]. No constan en el expediente la renta, los hogares, el nivel educativo ni el empleo del municipio.

Panel de salud

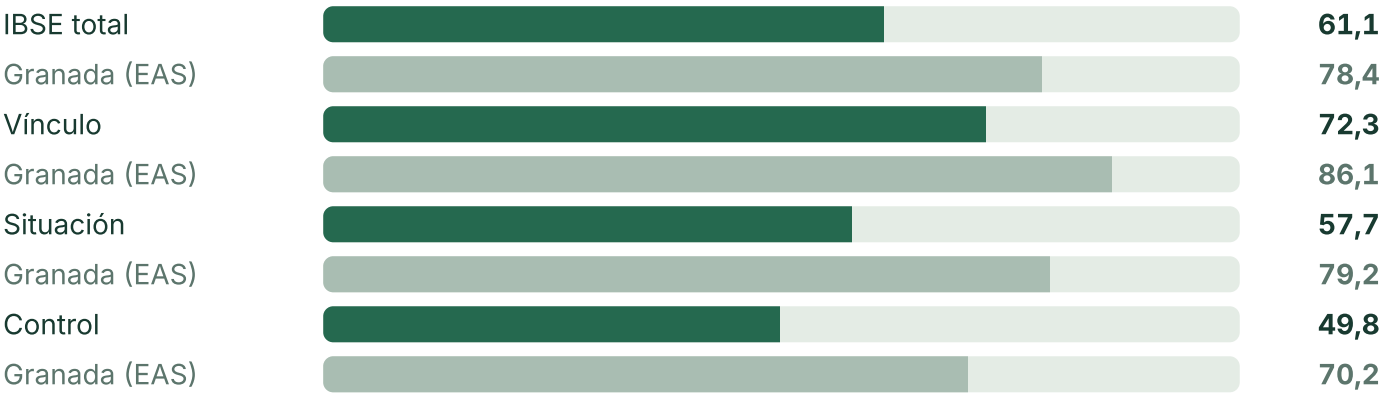
El Informe de Salud publica la morbilidad crónica registrada de 2024 con Granada como comparador [2, tabla 6] (figura 2); la mortalidad de 2022 y 2023 [2, tabla 3]; la incidencia de cáncer de 2015 a 2019 [2]; la vigilancia de 2024 y 2025, con el Distrito y Andalucía como comparadores para las infecciones de transmisión sexual [2, tabla 9]; la cobertura vacunal y los cribados [2, tablas 10 a 12]. El Monitor aporta el bienestar socioemocional de 2026 en una escala común de 0 a 100, con la provincia de Granada de la Encuesta Andaluza de Salud de 2023 como referencia no local [3] [6] (figura 3). Sin intervalos de confianza publicados, el panel no marca mejor ni peor.

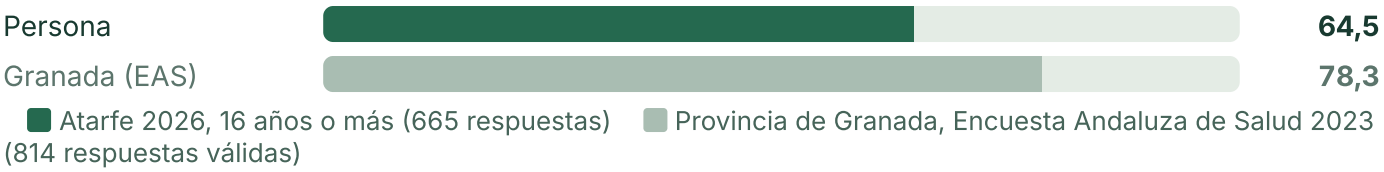
Morbilidad crónica registrada · casos por 10.000 habitantes · 2024

Diagnóstico	Atarfe	Granada	Atarfe mujeres	Atarfe hombres
Dislipemia	2.332,12	2.656,45	2.422,55	2.240,79
Hipertensión	1.952,16	2.289,39	1.984,80	1.919,19
Artrosis, espondilosis	1.830,76	2.009,28	2.256,76	1.400,47
Asma	1.508,96	1.402,49	1.558,46	1.458,95
Trastorno de ansiedad	1.126,49	1.030,68	1.522,92	726,08
Diabetes	865,12	898,39	764,28	966,98
Hipotiroidismo	771,77	917,89	1.265,22	273,36
Obesidad	599,99	553,83	668,14	531,16
Dependencia del tabaco	576,74	611,13	538,92	614,94
Litiasis urinaria	390,17	356,51	432,24	347,69

Fuente: Informe de Salud de Atarfe (21/11/2025), tabla 6.

Bienestar socioemocional (IBSE) · escala 0–100





> La referencia de Granada es «no local» y procede de una encuesta con entrevista en el hogar y muestra probabilística; el Monitor de Atarfe se respondió en papel o por QR, con muestra voluntaria. La diferencia entre las dos barras no puede leerse como diferencia de bienestar sin separar el efecto del modo de respuesta.

Fuentes: Monitor de bienestar socioemocional Atarfe 2026; Encuesta Andaluza de Salud 2023, submuestra de Granada (cálculo propio desde microdatos, fixture de COMPÁS). Ambas en escala común 0–100 (anexo C).

Mortalidad y cáncer

Indicador	Atarfe	Periodo y fuente
Defunciones totales	113 → 109	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Enfermedades del sistema circulatorio	38 → 27	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Tumores	27 → 24	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Enfermedades del sistema respiratorio	11 → 15	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Casos de cáncer	457	2015–2019 · Informe, discusión
Incidencia de cáncer, tasa estandarizada / bruta (por 100.000)	718,6 / 499,3	2015–2019 · Informe, discusión

Prevención y vigilancia

Indicador	Atarfe	Distrito	Andalucía	Periodo
Cribado de cáncer de mama: participación sobre invitadas	80,57 %	—	—	Informe, tabla 11
Cribado de cáncer de mama: participación sobre población elegible	58,70 %	—	—	Informe, tabla 11
Cribado de cáncer de colon: participación sobre población elegible	42,97 %	—	—	Informe, tabla 12
Vacunación infantil: primovacunación	98,54 %	—	—	2024 · Informe, tabla 10
Infecciones de transmisión sexual (por 100.000)	151,28	292,09	175,10	2024 · Informe, tabla 9
Tosferina, casos declarados	37	—	—	2024–2025 · Informe, tabla 7

Desigualdad

La media de Atarfe esconde diferencias que el expediente solo permite ver en parte. No hay datos por sección censal, así que la página se limita a sexo y edad.

Mujeres y hombres. El trastorno de ansiedad registrado alcanza 1.522,92 casos por 10.000 mujeres y 726,08 por 10.000 hombres; el hipotiroidismo, 1.265,22 y 273,36. Los hombres tienen más casos de cardiopatía isquémica, 275 frente a 101, de EPOC, 501 frente a 305, y de diabetes, 928 frente a 742 [2, tablas 4 a 6]. En el Monitor, las mujeres puntúan 61,0 y los hombres 64,3 [3].

Edad. El índice del Monitor es de 67,6 entre los 13 y los 15 años, de 63,3 entre los 16 y los 24, de 59,5 entre los 25 y los 64 y de 63,3 a partir de los 65 [3] (figura 4). La diferencia entre mujeres y hombres es mayor entre los 16 y los 24 años, 59,0 frente a 68,0 [3].

Por sexo y edad · IBSE total, escala 0–100

Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Diferencia	Respuestas (H / M)
13–15	69,9	65,2	-4,7	72 / 73
16–24	68,0	59,0	-9,0	62 / 67
25–44	61,4	58,6	-2,8	56 / 120
45–64	57,8	60,4	+2,6	77 / 139
65+	65,1	62,9	-2,2	27 / 117
Total	**64,3**	**61,0**	**-3,3**	294 / 517

Monitor Atarfe 2026, 810 respuestas válidas con edad asignable. Medias de la muestra participante; los grupos con menos de 30 respuestas se leen con especial cautela (hombres de 65 o más: 27).

Lo que no se ve. Sin renta ni salud por sección censal no puede saberse si alguna zona del municipio concentra la desventaja. Que no se observe no significa que no exista.

1. Punto de partida

Atarfe es un municipio metropolitano de la Vega de Granada que crece y recibe población: 20.952 habitantes en 2025 [1], un 16,4 % más que en 2014 [2, tabla 1]. El Pleno aprobó la adhesión a la Red Local de Acción en Salud el 28 de noviembre de 2024 y el Ayuntamiento firmó el formulario de adhesión el 12 de marzo de 2025 [7]. El Grupo Motor está constituido. El 27 de febrero de 2026 se celebró el taller de impulso, con el Ayuntamiento, el centro de salud, el equipo directivo de los servicios de salud mental comunitaria, asociaciones y ciudadanía [8]; una reunión posterior presentó los resultados del Monitor. No hay actas de esas reuniones.

Lo que se sabe hoy de la salud de Atarfe procede del Informe de la situación de salud de Epidemiología del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, de 21 de noviembre de 2025 [2]; del Monitor de bienestar socioemocional, que el Ayuntamiento y el Distrito pasaron entre el 6 de marzo y el 26 de abril de 2026, con 910 respuestas y 811 válidas de personas de 13 a 88 años [3]; y de los 20 recursos de Atarfe en Localiza Salud [4]. El Monitor sustituyó a un proyecto de encuesta de salud de 691 entrevistas diseñado en 2025 [10].

Las fórmulas del cuestionario del Monitor en REDCap no medían los cuatro factores en la misma escala: Vínculo solo podía llegar a 75 y Situación y Control empezaban en 25. Este Perfil usa los valores recalculados desde las ocho preguntas en una escala común de 0 a 100 [3] [9]; el cambio no afecta a las respuestas, pero sí al orden de los factores.

No constan la renta, el empleo, la vivienda ni el nivel educativo del municipio y de sus secciones censales; ninguna priorización ciudadana; las actas del Grupo Motor; la validación de los recursos de Localiza Salud como activos; ni datos de salud de un ciclo anterior medidos de la misma manera. Es el primer ciclo diagnóstico de Atarfe en la Red.

2. Conclusiones

Una lectura de conjunto

Las ocho conclusiones describen un municipio joven, que crece y cuya carga de enfermedad sigue el patrón de la provincia. Lo que distingue a Atarfe en los registros sanitarios son cuatro diagnósticos más frecuentes que en Granada, el asma, el trastorno de ansiedad, la obesidad y la litiasis urinaria, y una distribución muy desigual por sexo del trastorno de ansiedad [2, tabla 6].

El Monitor, una fuente independiente y construida de otra manera, apunta en la misma dirección: el componente más bajo del bienestar es el que recoge la energía y la tranquilidad, y puntúan más bajo las mujeres y las personas en edad de trabajar [3]. Esa coincidencia es el hallazgo central del Perfil, y es una coexistencia observada en el territorio, no una explicación de sus causas.

Frente al malestar, el diagnóstico encuentra capacidades: relaciones personales que la mayoría valora bien, una respuesta de 910 personas a una encuesta voluntaria y 20 recursos registrados. Faltan los datos que permitirían relacionar la salud con las condiciones de vida del municipio y de sus barrios (C1).

C1. Atarfe es un municipio joven y en crecimiento, y no hay datos que muestren cómo se reparten dentro de él las condiciones de vida.

La población creció un 16,4 % entre 2014 y 2024, con una edad media de 39 años y un 13,1 % de mayores de 65 [2, tabla 1]; en 2025, el 13,4 % [1]. El saldo migratorio fue positivo en 2023 y Marruecos es el primer país de procedencia de la población extranjera, con el 31,3 % [2, introducción]. El 94,3 % de la población vive en agrupaciones urbanas [5]. Es la estructura de un municipio metropolitano que recibe población; el expediente no permite saber cómo se distribuyen la renta, el empleo o la vivienda entre zonas, ni si la población que llega se concentra en alguna de ellas.

Lleva a R1.

C2. La enfermedad crónica sigue el patrón provincial, con más asma, trastorno de ansiedad, obesidad y litiasis urinaria que en Granada.

Las primeras causas de muerte en 2023 fueron las enfermedades circulatorias, 27 defunciones, y los tumores, 24, como en la provincia y en Andalucía; las respiratorias pasaron de 11 a 15 entre 2022 y 2023 [2, tablas 2 y 3]. La dislipemia, con 2.332,12 casos por 10.000 habitantes, y la hipertensión, con 1.952,16, son los diagnósticos más frecuentes, con valores inferiores a los de Granada. Son superiores a Granada el asma, 1.508,96 frente a 1.402,49, el trastorno de ansiedad, 1.126,49 frente a 1.030,68, la obesidad, 599,99 frente a 553,83, y la litiasis urinaria, 390,17 frente a 356,51 [2, tabla 6].

Lleva a R2.

C3. Dos fuentes independientes coinciden en señalar el malestar emocional, y en ambas pesa más en las mujeres.

El trastorno de ansiedad registrado es más prevalente en Atarfe que en Granada y, dentro del municipio, duplica en las mujeres, 1.522,92 casos por 10.000, el valor de los hombres, 726,08 [2, tabla 6]. En el Monitor, el factor Control es el más bajo de los cuatro, 51,1 sobre 100: el 50,7 % se sintió tranquilo solo en algún momento o en ninguno durante la última semana, y el 46,1 % con energía solo en algún momento o en ninguno. Las mujeres puntúan por debajo de los hombres en el índice total, 61,0 frente a 64,3, y en Control, 49,0 frente a 54,8 [3]. Es una coexistencia observada en el mismo ciclo; no demuestra que una cosa explique la otra.

Lleva a R4 y R5.

C4. El bienestar más bajo está en la edad de trabajar, y la brecha entre mujeres y hombres se abre en la juventud.

El índice total es de 67,6 entre los 13 y los 15 años, baja a 63,3 entre los 16 y los 24 y se queda en 59,5 entre los 25 y los 64, donde Control cae a 45,5 en el tramo de 25 a 44 y a 47,4 en el de 45 a 64 [3]. Entre los 16 y los 24 años los hombres puntúan 68,0 y las mujeres 59,0; entre los 13 y los 15 la diferencia es menor, 69,9 frente a 65,2 [3]. Las personas de 25 a 64 años son, además, las que menos respondieron en proporción a su peso en el padrón, sobre todo los hombres (C6).

Lleva a R5 y R6.

C5. Las relaciones sostienen el bienestar de la mayoría, pero una de cada cinco personas se sintió sola buena parte del tiempo.

Vínculo es el factor más alto, 72,4, y apenas varía con la edad. Aun así, el 18,4 % se sintió solo buena parte del tiempo o casi siempre durante la última semana, y el 16,2 % deprimido [3]. Entre las personas de 65 o más años, el 11,1 % no se sintió feliz en ningún momento o casi en ninguno y otro 11,1 % no disfrutó de la vida, frente a menos del 5 % entre los 13 y los 44 años [3].

Lleva a R5 y R7.

C6. La participación en el Monitor es en sí misma una capacidad del municipio, y su muestra no reproduce la población.

Se reunieron 910 respuestas en siete semanas [3]. Para la población de 15 o más años, 17.205 personas [1], una muestra aleatoria de 376 habría bastado como referencia; se reunieron 752 respuestas válidas de ese tramo. La muestra no es aleatoria y se aparta del padrón: las mujeres son el 64,8 %, frente al 50,4 %; las personas de 15 a 24 años, el 28,7 %, frente al 13,9 %; y los hombres de 65 o más, el 3,6 %, frente al 7,3 % [3] [1]. Reponderar por edad y sexo apenas cambia el índice total, 61,2 frente a 62,0 observado, pero no corrige quién eligió responder.

Lleva a R6.

C7. Los recursos registrados centrados en el malestar emocional son sanitarios; los comunitarios se dirigen sobre todo a mayores, a jóvenes o a toda la población.

De los 20 recursos de Atarfe en Localiza Salud, 11 declaran la temática de bienestar emocional [4]. Cuatro están en el centro de salud: el Grupo de Afrontamiento de la Ansiedad, el Grupo Socioeducativo, el Taller de sueño saludable y la Unidad de salud mental comunitaria, que atiende a pacientes con necesidad de seguimiento. Los comunitarios se dirigen a personas mayores, como el Centro de Participación Activa y su taller de coro; a adolescentes y jóvenes, como el Espacio Joven; o a toda la población, como el Centro Cívico, la Asociación Artística y Cultural y los Talleres Artísticos. Entre los comunitarios, solo el Centro de Educación de Personas Adultas y los Talleres Artísticos declaran a las personas de 30 a 64 años entre sus destinatarios [4]; ninguno se dirige a la población en edad de trabajar en particular, la de bienestar más bajo (C4). La validación de estos recursos como activos para la salud no está declarada, y el Centro de Participación Activa figura dos veces.

Lleva a R7 y R8.

C8. La prevención alcanza a casi toda la infancia y a la mayoría de las mujeres invitadas al cribado de mama, y a menos de la mitad de la población elegible para el de colon.

La cobertura vacunal supera el 96 % en todos los indicadores del informe [2, tabla 10]. En el cribado de cáncer de mama participa el 80,57 % de las mujeres invitadas, el 58,70 % de la población elegible; en el de colon, el 42,97 % de la población elegible [2, tablas 11 y 12].

Lleva a R3.

3. Convergencias y divergencias

Coinciden. El Informe registra más trastorno de ansiedad que en Granada y el doble en las mujeres [2, tabla 6], y el Monitor sitúa en el factor Control el bienestar más bajo, también menor en las mujeres [3]. Las dos fuentes miden cosas distintas: una cuenta diagnósticos en la historia clínica de quien consulta; la otra recoge cómo se sintió durante una semana quien quiso responder. Que apunten en la misma dirección aumenta la solidez de la lectura; no la convierte en una medida de prevalencia.

Discrepan. Las personas de 16 o más años que respondieron en Atarfe puntúan 61,1 en el índice; la provincia de Granada, en la Encuesta Andaluza de Salud de 2023, 78,4 [3] [6]. La diferencia es grande y se da en los cuatro factores, pero puede deberse al modo de respuesta, cuestionario autoadministrado frente a entrevista personal, a la selección de quien responde y a los tres años entre ambas mediciones. Con la información disponible no puede atribuirse a ninguna de esas causas.

Sin contraste. Las defunciones por enfermedades respiratorias pasaron de 11 a 15 entre 2022 y 2023 y el asma registrada supera el valor provincial [2, tablas 3 y 6]. Ninguna otra fuente del expediente trata la salud respiratoria ni el entorno.

4. Lo que no sabemos

Cómo se reparten la renta, el empleo, la vivienda y el nivel educativo en el municipio y por sección censal (afecta a C1, C3 y C4). Dónde se puede saber: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2024; IECA, ficha municipal del SIMA.

Cuál es el bienestar emocional de la población con una muestra probabilística y el mismo modo de respuesta que la referencia (afecta a C3 y C6). Dónde se puede saber: segundo Monitor con el cuestionario corregido, selección aleatoria o cuotas por edad y sexo.

Cómo viven su bienestar las personas de 25 a 64 años, sobre todo los hombres (afecta a C4 y C6). Dónde se puede saber: respuestas de ese tramo en centros de trabajo, asociaciones y AMPA; material cualitativo del Grupo Motor.

Qué recursos funcionan como activos para la gente: hay 20 recursos registrados y ningún activo validado declarado (afecta a C7). Dónde se puede saber: mapeo de activos con la comunidad tras la priorización, con registro y validación en Localiza Salud.

Qué prioriza la ciudadanía (afecta a C3, C4, C5 y C7). Dónde se puede saber: priorización temática o por líneas estratégicas con el Grupo Motor.

Por qué participa menos de la mitad de la población elegible en el cribado de colon (afecta a C8). Dónde se puede saber: programa de cribado y centro de salud.

5. Recomendaciones del Perfil

Ocho propuestas que derivan de las conclusiones. Qué se hace primero, quién lo hace y con qué recursos lo decidirán el Grupo Motor y el Plan de Acción.

CONOCER Recuperar los datos que faltan

R1. Incorporar al expediente la renta por sección censal y los indicadores de empleo del municipio, para ver dónde se concentran las condiciones de vida más desfavorables.

Deriva de C1.

R6. Repetir el Monitor con el cuestionario corregido y con un procedimiento que alcance a las personas de 25 a 64 años y a los hombres mayores, y separar el efecto del modo de respuesta antes de compararlo con la Encuesta Andaluza de Salud.

Deriva de C4, C6.

R8. Después de la priorización, mapear con la comunidad los activos vinculados a las líneas que elija el Grupo Motor, validar como activos los recursos de Localiza Salud que cumplan los criterios y resolver el posible duplicado del Centro de Participación Activa.

Deriva de C7.

CONTRASTAR Preguntar a quien lo vive

R2. Contrastar con el centro de salud y con Epidemiología qué hay detrás de la mayor prevalencia registrada de asma, obesidad y litiasis urinaria y del aumento de la mortalidad respiratoria.

Deriva de C2.

R3. Contrastar con el centro de salud por qué participa en el cribado de colon menos de la mitad de la población elegible.

Deriva de C8.

R4. Contrastar con el Grupo Motor y con los servicios de salud mental comunitaria la lectura conjunta de la ansiedad registrada y del factor Control, y en qué grupos de población la reconocen.

Deriva de C3.

ABORDAR Empezar a actuar donde hay fundamento

R5. Trabajar el bienestar emocional y la salud mental como área del Plan, con atención a las mujeres y a las personas en edad de trabajar, apoyándose en la coexistencia observada en el municipio entre la ansiedad registrada y el bajo control percibido.

Deriva de C3, C4, C5.

R7. Trabajar la soledad no deseada y la pérdida de disfrute de las personas mayores desde los recursos que ya se dirigen a ellas.

Deriva de C5, C7.

6. Paso al Plan de Acción

El Grupo Motor recibe las conclusiones que el equipo técnico elija, las ocho recomendaciones y las preguntas abiertas. A partir de aquí decide qué priorizar, y el Plan de Acción fija las líneas, los objetivos y los indicadores del I Plan Local de Salud de Atarfe 2027-2030.

7. Autoría y validación

Validación. Pendiente. Responsable técnico, fecha de validación y consenso del Grupo Motor por registrar.

Autoría. Versión 0.1 redactada por Claude el 9-11-2026 y versión 0.2 el mismo día, a petición de Blas Ramón Hermoso Rico, técnico de educación para la salud y participación comunitaria del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, a partir del expediente de Atarfe. La versión 0.2 adopta la estructura del modelo de COMPÁS e incorpora los 20 recursos de Localiza Salud.

Referencias

1. Instituto Nacional de Estadística. Padrón municipal de habitantes, 2025. Tabla 68535, municipio 18022 Atarfe [Internet]**. Madrid: INE;** [consultado 14 oct 2026]**.**

2. Unidad de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, Distrito Sanitario Granada-Metropolitano (del Moral Campaña C, Molina Rueda MJ). Informe de la situación de salud en el municipio de Atarfe. Granada: Servicio Andaluz de Salud; 21 de noviembre de 2025.

3. Ayuntamiento de Atarfe; Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. Monitor de bienestar socioemocional Atarfe 2026 (REDCap). Exportación de datos de 5 de noviembre de 2026; cálculo en escala común 0-100.

4. Ministerio de Sanidad. Localiza Salud. Recursos del municipio de Atarfe (20 registros) [Internet]**. Tabla aportada el 9 de noviembre de 2026.**

5. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. BADEA, consulta 19824: porcentaje de población según tipología de celda y grado de urbanización por municipio, 2024.

6. Consejería de Salud y Consumo. Encuesta Andaluza de Salud 2023, submuestra de la provincia de Granada. Índice de Bienestar Socioemocional, cálculo propio desde microdatos en escala común 0-100.

7. Ayuntamiento de Atarfe. Certificado del acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2024 (expediente 7785/2024) y formulario de adhesión a la RELAS de 12 de marzo de 2025.

8. Ayuntamiento de Atarfe; Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. Guion del taller de impulso del Plan Local de Salud, 27 de febrero de 2026.

9. Bericat E. The Socioemotional Well-Being Index (SEWBI): theoretical framework and empirical operationalisation. Soc Indic Res. 2014;119(2):599-626.

10. Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. Encuesta de salud de la población de Atarfe: justificación técnica, diseño muestral y presupuesto. Documento de trabajo; 2025.

Anexos

Evidencia compilada, cálculos y trazabilidad.

A. Trazabilidad de las conclusiones

Conclusión	Tipo	Evidencias principales	Relación	Límite principal	Rec.
C1	Hecho	Informe, tabla 1 e introducción; INE 2025; BADEA 19824	Sin relación declarada	Sin datos socioeconómicos ni por sección	R1
C2	Hecho	Informe, tablas 2, 3 y 6	Sin relación declarada	Comparación sin intervalos publicados	R2, R3
C3	Interpretación	Informe, tabla 6; Monitor IBSE 2026, factor Control e ítems	Grado 1 · coexistencia observada	Muestra no probabilística; medidas distintas	R4, R5
C4	Hecho	Monitor IBSE 2026 por edad y sexo	Sin relación declarada	Grupos pequeños; menor respuesta de 25–64	R5, R6
C5	Hecho	Monitor IBSE 2026, Vínculo e ítems por edad	Grado 1 · coexistencia con recursos para mayores (C7)	Hombres de 65 o más: 27 respuestas	R5, R7
C6	Hecho	Monitor IBSE 2026; INE 2025; SAM (COMPÁS)	Sin relación declarada	Selección voluntaria	R6
C7	Hecho	Localiza Salud, 20 recursos	Conexión activo-tema propuesta, pendiente de declarar	Validación no declarada	R7, R8
C8	Hecho	Informe, tablas 10, 11 y 12	Sin relación declarada	Sin comparadores publicados	R3

B. Monitor de bienestar socioemocional Atarfe 2026

Factor (preguntas)	Total	Hombres	Mujeres	13–15	16–24	25–44	45–64	65+
IBSE total	62,2	64,3	61,0	67,6	63,3	59,5	59,5	63,3
Vínculo (deprimido, solo)	72,4	73,8	71,6	73,1	71,6	70,6	73,1	73,5
Situación (feliz, disfrutar)	60,3	62,1	59,3	72,0	63,2	58,0	54,7	56,9
Control (energía, tranquilo)	51,1	54,8	49,0	57,2	54,0	45,5	47,4	54,9
Persona (optimista, bien consigo)	65,0	66,5	64,2	67,9	64,4	63,6	62,8	68,1

811 respuestas válidas (cuestionario completo y ocho preguntas contestadas) de 910 registros. Hombres 294, mujeres 517. Respuestas por edad: 13–15: 145, 16–24: 129, 25–44: 176, 45–64: 216, 65+: 144. Una respuesta con edad 1993 se excluye del desglose por edad.

Pregunta (última semana)	Total	Hombres	Mujeres
Se sintió deprimido/a buena parte del tiempo o casi siempre	16,2 %	12,2 %	18,4 %
Se sintió solo/a buena parte del tiempo o casi siempre	18,4 %	19,4 %	17,8 %
Se sintió feliz en ningún momento o casi ninguno	4,1 %	2,7 %	4,8 %
Disfrutó de la vida en ningún momento o casi ninguno	6,0 %	4,8 %	6,8 %
Rebosante de energía solo en algún momento o en ninguno	46,1 %	42,5 %	48,2 %
Tranquilo/a y relajado/a solo en algún momento o en ninguno	50,7 %	45,2 %	53,8 %
En desacuerdo con «he sido optimista respecto a mi futuro»	14,9 %	12,2 %	16,4 %
En desacuerdo con «me he sentido bien conmigo mismo/a»	12,0 %	10,5 %	12,8 %

C. Escala del IBSE y corrección de las fórmulas

Cada pregunta se lleva a una escala de 0 a 100 en la que más es mejor. Frecuencia de una emoción negativa (deprimido, solo): (4 − respuesta) / 3 × 100. Frecuencia de una emoción positiva (feliz, disfrutar, energía, tranquilo): (respuesta − 1) / 3 × 100. Acuerdo, donde 1 es «muy de acuerdo» (optimista, bien conmigo mismo): (5 − respuesta) / 4 × 100. Cada factor es la media de sus dos preguntas y el índice total, la media de los cuatro factores.

Factor	Fórmulas de REDCap (rango)	Valor con fórmulas de REDCap	Escala común
Vínculo	0–75	54,3	72,4
Situación	25–100	70,2	60,3
Control	25–100	63,3	51,1
Persona	0–100	65,0	65,0
IBSE total	12,5–93,75	63,2	62,2

La conversión entre ambas escalas es lineal y exacta (Vínculo × 4/3; Situación y Control (x − 25) × 4/3), y se ha aplicado también a la referencia de Granada de la Encuesta Andaluza de Salud 2023: total 78,4; Vínculo 86,1; Situación 79,2; Control 70,2; Persona 78,3. El diccionario de REDCap corregido está en COMPÁS (municipalities/atarfe/redcap).

D. Composición de la muestra del Monitor

Grupo	Padrón 2025 hombres	Muestra hombres	Padrón 2025 mujeres	Muestra mujeres
15–24	7,1 %	14,0 % (105)	6,8 %	14,8 % (111)
25–44	17,5 %	7,4 % (56)	17,9 %	16,0 % (120)
45–64	17,6 %	10,2 % (77)	16,7 %	18,5 % (139)
65 o más	7,3 %	3,6 % (27)	9,0 %	15,6 % (117)

Población de 15 o más años: 17.205 (INE 2025). Muestra teórica de referencia (Cochran, 95 %, ±5 %, p = 0,5, con corrección por población finita): 376; supone selección aleatoria y no es aplicable como margen de error a esta muestra. 752 respuestas válidas de 15 o más años. Celdas sin respuestas: 90 años o más (137 personas en el padrón). Media reponderada por edad y sexo (sensibilidad, sin validar): total 61,2; Vínculo 72,3; Situación 58,0; Control 49,6; Persona 64,8.

E. Recursos de Atarfe en Localiza Salud

ID	Recurso	Destinatarios	Temáticas en Localiza
61948	Asociación Artística y Cultural Ciudad Atarfe	Población general	Actividad física, Envejecimiento activo, Cultura y ocio, Escuela de salud/formación, Bienestar emocional
61912	Biblioteca Pública Municipal Marian Pineda de Atarfe	Población general	Cultura y ocio, Participación y acción comunitaria, Escuela de salud/formación
61919	Centro Cívico Almudena Grandes de Atarfe	Población general	Envejecimiento activo, Personas en riesgo de exclusión, Participación y acción comunitaria, Escuela de salud/formación, Bienestar emocional
no consta	Centro Cultural Medina Elvira	Población general	Cultura y ocio, Participación y acción comunitaria
61585	Centro de Participación Activa de Atarfe	Mayores de 64 años	Alimentación saludable, Actividad física, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria, Bienestar emocional
61419	Centro de Participación Activa de Atarfe	Otros	Alimentación saludable, Actividad física, Envejecimiento activo, Cultura y ocio, Participación y acción comunitaria
61587	Centro Público de Educación de Personas Adultas Mariana Pineda de Atarfe	Mayores de 64 años, Adultos (30-64 años)	Alimentación saludable, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria, Escuela de salud/formación, Bienestar emocional
no consta	Club de senderismo Castillejo	Población general	Actividad física, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria
61945	Espacio Joven Atarfe	Jóvenes (18-29 años), Adolescentes (12-17 años)	Cultura y ocio, Participación y acción comunitaria, Bienestar emocional

ID	Recurso	Destinatarios	Temáticas en Localiza
61427	GIMNASIA MENTAL	Otros	Otros
47600	Grupo de Afrontamiento de la Ansiedad en Atención Primaria (GRAFA)	Jóvenes (18-29 años), Mayores de 64 años, Adultos (30-64 años)	Bienestar emocional
61584	Grupo Socioeducativo (GRUSE - Centro de Salud de Atarfe)	Jóvenes (18-29 años), Mayores de 64 años, Adultos (30-64 años)	Participación y acción comunitaria, Género/identidad, Bienestar emocional
47602	Piscina Cubierta Pública Atarfe (Granada)	Población general	Actividad física, Envejecimiento activo
60152	Punto Vuela Atarfe	Población general	Otros
61944	Radio Ilíberis 101.5 FM de Atrafe	Población general	Cultura y ocio, Participación y acción comunitaria
61425	Taller de Coro del Centro de Participación Activa de Atarfe	Otros	Alimentación saludable, Envejecimiento activo, Cultura y ocio, Participación y acción comunitaria, Bienestar emocional
61429	Taller de Senderismo del Centro de Participación Activa de Atarfe	Otros	Actividad física
63552	Taller de sueño saludable	Jóvenes (18-29 años), Mayores de 64 años, Adultos (30-64 años)	Participación y acción comunitaria, Enfermedades crónicas, Bienestar emocional
61922	Talleres Artísticos Ciudad de Atarfe	Jóvenes (18-29 años), Adolescentes (12-17 años), Mayores de 64 años, Adultos (30-64 años)	Envejecimiento activo, Cultura y ocio, Bienestar emocional
no consta	Unidad de salud mental comunitaria de Atarfe	Población general	Prevención del suicidio, Otras adicciones, Enfermedades crónicas, Escuela de salud/formación, Bienestar emocional

Tabla de Localiza Salud aportada el 9/11/2026 (20 registros); textos literales, incluidas las erratas de origen. El identificador procede de la tabla del 5/11/2026 cuando coincide; los tres registros nuevos no lo traen. No se ha verificado en línea la vigencia de cada ficha.